

A) classification:

Classe chimique	DCI	Spécialité
Phénothiazines	- Alimémazine - Chlorpromazine - Fluphénazine dichlorhydrate - Lévomépromazine - Pipotiazine - Propériciazine	- Théralène® - Largactil® - Moditen® - Nozinan® - Piportil® - Neuleptil®
Butyrophénones	- Halopéridol	- Haldol®
Benzamides	- Amisulpride - Sulpiride	- Solian® - Dogmatil®
Thioxanthènes	- Flupentixol	- Fluanxol®
Autres structures tricycliques	- Clozapine - Olanzapine - Quétiapine	- Léponex® - Zyprexa®
Structures bicycliques	- Risperidone - Ziprasidone	- Risperdal® - Zeldox®

B) Indications des neuroleptiques:

- États psychotiques aigus et chroniques.
- Mouvements anormaux (maladie de Huntington, syndrome de Gilles de la tourette).
- Certains cas (TOC, troubles psychosomatiques).
- États d'agitations, d'agressivité et d'impulsivité, d'angoisse extrême.
- Algies intenses (cancer, névralgie du trijumeau, zona).
- Troubles endocriniens (bouffées de chaleur).
- Vomissements d'origine centrale et périphérique.
- En anesthésie (prémédication).

* Contre-indications des neuroleptiques:

- Absolues:

- 1) Phéochromocytome (Benzamides surtout).
- 2) Défaillance poly-viscérale, Comas.

- **à l'arrêt**: effet rebond.

- **si arrêt brutal**: syndrome de sevrage (tremblements, crampes, nausées...).

- après un traitement long (= + de 4 semaines) ou à fortes doses, l'arrêt doit se faire sur plusieurs semaines, en diminuant les doses progressivement.

- La prescription est maintenant réglementée et limitée à 4 ou 12 semaines, selon les produits et il est recommandé d'administrer la dose minimale efficace.

*** Risque en cas de surdosage:**

- Contrairement aux barbituriques, le surdosage de BZD seules ne met pas en danger la vie du patient: il justifie néanmoins une hospitalisation en réanimation.

*** Terrains fragiles vis-à-vis des benzodiazépines:**

- **les personnes âgées**: car les effets secondaires sont plus lourds de conséquences: l'amnésie, les pertes cognitives, risque d'induction d'un syndrome confusionnel, l'effet myorelaxant peut entraîner des pertes d'équilibre et perturbe la déglutition (risque de *fausses routes*).

- **l'insuffisant respiratoire**, à cause de l'effet myorelaxant.

- **l'insuffisant hépatique et rénal**, il faut adapter la posologie.

- **la grossesse et l'allaitement**: aucun effet tératogène n'a été mis en évidence mais il faut éviter ces traitements le 1^{er} et le dernier trimestre.

*** les problèmes posés par les anxiolytiques et les hypnotiques:**

- Médicaments très souvent détournés (mésusage) dans un but toxicomane.

- Fréquence des ordonnances falsifiées: pharmacien doit être vigilant et doit relever les irrégularités et les prescriptions illogiques.

- Aggressions dans les officines le plus souvent en rapport avec vol d'anxiolytiques et d'hypnotiques.

- relâchement, relaxation musculaire, décontraction en particulier *le Valium*.

*** action anticonvulsivante:**

- certains sont utilisés comme antiépileptiques: Klonopin *et le Valium*.

B) Les anxiolytiques autres que les benzodiazépines:

- Hydroxyzine = *ATARAX*

Il n'entraîne pas de dépendance mais son activité est inconstante.

C) Les hypnotiques autres que benzodiazépiniques :

- IMOVANE:

- mécanisme d'action très voisin des BZD, mais il respecterait mieux l'architecture du sommeil.
- mêmes effets indésirables, même dépendance.
- son élimination est en partie salivaire, ce qui explique qu'il laisse un goût amer dans la bouche au réveil.

- STILNOX:

- action sur le GABA.
- respect du sommeil paradoxal.
- mêmes effets secondaires que les BZD.

- **MEPRONIZINE:** = association d'un Neuroleptique (phénothiazine) et d'un carbamate.

*** Effets secondaires:**

- Ils sont en rapport avec la posologie, la durée du traitement et la sensibilité individuelle du patient.
- Les troubles de la vigilance = la somnolence: effet résiduel des hypnotiques le matin, effet secondaire gênant des anxiolytiques ; attention aux conducteurs de voitures ou de machines; ces troubles sont accentués par la prise concomitante d'alcool.
- Les troubles cognitifs = amnésie antérograde, observés surtout avec la voie injectable et chez les personnes âgées.

1) Maladies neurologiques:

- Antécédent d'arriération ou d'encéphalite (risque de syndrome malin accru).
- Myasthénie.
- Epilepsie.
- Maladies neurologiques évolutives (SEP, Parkinson).

2) Porphyrisme.

3) Glaucome à angle fermé et troubles uréthro- prostatiques.

4) Troubles Hématologiques: Neutropénies, antécédent d'agranulocytose toxique, Hémopathie toxique : Proscrire Clozapine+++.

5) Insuffisance Rénale, Hépatique, Cardiaque.

6) Sujet âgé: Eviter molécules trop sédatives, incisives ou trop anticholinergiques.

7) Grossesse: Eviter 1er T même si risque tératogène est faible; Renoncer à allaitement; Haldol et Largactil autorisés.

III- Les Antidépresseurs:

- Psychotropes appartenant au groupe des psychoanaleptiques (Delay et Deniker 1953).
- Améliorent l'humeur déprimée en agissant sur l'ensemble du syndrome dépressif.

*** Contre- indications:**

1- Absolues:

- Glaucome aigu à angle fermé.
- Hypertrophie bénigne de la prostate.
- Cardiopathie non stabilisées.
- IDM.
- Insuffisance cardiaque décompensée.
- 1^{er} trimestre de grossesse.
- Association avec IMAO non sélectifs.

- Épilepsie.
- Insuffisance hépatique et rénale.

IV- Les Thymorégulateurs:

- L'action normothymique ou thymorégulatrice est une action régulatrice de l'humeur.
- Les indications sont majoritairement les troubles bipolaires.